3.1.6 생애말기환자 관리			
규 정 번 호	3.1.6	제 정 일	3주기 규정집 제정
관 련 인증기준	3.1.6 생애말기환자 관리	최근 개정일	2025-10-15
담 당 부 서	진료부, 간호부, 원무과	시 행 일	2025-11-01
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	2027-10-15
관 련 근 거	1. 연명의료결정법(호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료결 관한 법률)		

▣ 목적 (Purpose)

의료기관은 생애말기환자의 존엄성과 편안함 유지를 위해 통증과 증상 완화 및 신체적, 정신적, 사회적, 영적 지지를 제공한다.

▣ 정책 (Policy)

1. 생애말기환자 진료에 대한 규정이 있다.
2. 직원은 생애말기환자 관리에 관한 교육을 받고, 그 내용을 이해한다.
3. 생애말기환자의 희망을 고려하여 적절한 대증치료를 제공한다.
4. 생애말기환자에게 정신 · 사회적 지지를 제공한다.

▣ 용어 정의 (Definition)

- 생애말기(End of life care) : 생애말기란 환자의 가족, 의료진이 질환의 경과 상 삶이 제한적이라는 것을 인지하는 기간을 말한다.
- 호스피스 : 죽음을 앞둔 생애말기환자와 그의 가족을 사랑으로 돌보는 행위로서, 남은 여생동안 인간으로서의 존엄성과 높은 삶의 질을 유지할 수 있도록 신체적, 정서적, 사회적, 영적인 돌봄을 통해 삶의 마지막 순간을 평안하게 맞이할 수 있도록 하며, 사별 후 가족이 갖는 고통과 슬픔을 잘 극복할 수 있도록 돕는 총체적 돌봄
- 완화의료 : 적극적인 의학적 치료의 대상이 되지 않으며, 근원적인 회복의 가능성이 없고, 점차 증상이 악화되어 몇 개월 내에 사망할 것으로 예상되는 암환자(말기암환자) 또는 말기 만성질환자 및 그 가족의 삶의 질 향상을 목적으로 하는 의료로써, 통증과 증상의 완화를 포함한 신체적, 심리사회적, 영적 영역에 대한 종합적인 평가 및 치료(암관리법 제2조)

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 생애말기환자 대상에 대한 정의

가. 호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료 결정에 관한 법률에 따라 '임종과정에 있는 환자' 란 담당의사와 해당 분야의 전문의 1명으로부터 임종과정에 있다는 의학적 판단을 받은 자를 말하며 '말기환자란' 적극적인 치료에도 불구하고 근원적인 회복의 가능성이 없고 점차 증상이 악화되어 담당의사와 해당 분야의 전문의 1명으로부터 수개월 이내에 사망할 것으로 예상되는 진단을 받은 환자를 말한다.

2. 생애말기환자 대상 질환

가. 암

나. 후천성면역결핍증

다. 만성폐쇄성 호흡기 질환

라. 만성 간경화

3. 생애말기환자 지정 기준

가. 담당의사가 생애말기 환자 여부를 진단하는 경우에는 다음 각 호의 기준을 종합적으로 고 려해야 한다.

1) 임상적 증상
2) 다른 질병 또는 질환의 존재 여부
3) 약물 투여 또는 시술 등에 따른 개선 정도
4) 종전의 진료 경과
5) 다른 진료 방법의 가능 여부

4. 생애말기환자 진료에 참여하는 직원의 교육 내용

가. 말기환자에 대한 교육은 년 1회 실시하며, 교육은 집체교육 및 온라인 교육 등으로 실시한다.

1) 죽음에 대한 인식
2) 생애말기환자에 대한 정서적지지 방법 등 요구를 효율적으로 해소하는 방법
3) 연명의료 결정 제도
4) 생애말기환자와의 효과적인 의사소통방법
5) 주의사항

5. 생애말기환자의 희망을 고려한 적절한 대증치료 제공

가. 환자 또는 보호자 설명 및 치료결정에 참여

1) 말기환자는 생명을 연장시키는 치료가 아닌, 고통을 받는 증상에 대한 치료가 중요하므로 환자 또는 보호자에게 증상에 대한 치료에 대해 설명하고 치료결정시 참여시킨다.

나. 적절한 대증치료(환자의 적정한 통증관리 등 증상 조절)제공

1) 마사지, 전신침상목욕 등을 통해서 통증을 완화시켜준다.
2) 상황이 허락하는 한 먹는 진통제를 우선 사용한다.
3) 약을 건너뛰거나 통증이 심해질 때까지 기다리지 않고 항상 시간에 맞추어 규칙적으로 복용한다. 이렇게 하는 것이 약물의 혈중 농도를 항상 일정하게 유지하여 암성통증을 예방할 수 있도록 해준다.
4) 진통제 복용후 통증조절이 잘되고 있는지 자주 평가하여 담당의사에게 이야기하고 통증 조절이 부족하면 진통제 처방을 변경 받도록 한다.

다. 영양관리: 경관영양과 정맥영양

1) 말기암 환자의 50% 정도는 식품과 수분의 공급이 저하되어도 배고픔을 느끼거나 갈증을 느끼지 않는다. 경관영양과 정맥영양의 주요 목적은 환자의 영양상태를 호전시키고 영양실조에 의해 나타나는 증상을 완화하는데 있다. 이러한 인공적인 영양공급이 필요 하다고 판단되는 환자의 경우 장기 기능에 장애가 있는 경우를 제외하고는 경관영양을 권장한다.
2) 정맥영양의 경우 영양상태 호전을 가져오기 위해서는 상당한 기간동안의 영양공급이 이루어져야 하고 따라서 환자의 수명이 그리 길지 않은 경우는 정맥영양의 효과를 보기는 어렵다.

3) 암조직의 성장으로 인한 사망보다 영양실조로 사망할 위험이 더 큰 환자의 경우는 정맥 영양공급이 생존기간 연장에 도움이 될 수 있다. 따라서 정맥 영양 공급은 모든 말기 암환자에 일괄적으로 적용되어야 하는 부분이라기 보다는 환자 개인별 필요에 따라 활용되어야 하며 특히 환자나 가족들의 심리적인 안정만을 고려하여 사용되지 않도록 한다.

라. 수분공급

1) 정맥을 통한 수분공급은 탈수로 인한 각종 증상들을 완화시킬 수 있다.
2) 구강 건조증이나 갈증은 수분 공급과 무관한것으로 보이나 메스꺼움은 하루 1L정도의 수분을 공급한 경우 완화된다.
3) 약물은 구강 건조증을 유발할 수 있으므로 이 경우에는 수분으로 자주 입술을 축여 주고 입술에 수분을 공급할 수 있는 윤활제를 발라주는 것도 효과적이다.

마. 영적지지

1) 자신의 사용
   가) 자신을 치유의 도구로 사용한다. 대상자 곁에 있어주고 친절과 인내, 사랑과 정겨움,바람직한 태도로 대상자를 대한다.
   나) 잘 들어 주는 것, 감정이입, 민감성, 겸손, 헌신적인 태도가 필요하다. 잘 듣기 위해 서는 귀와 눈과 마음을 열도록 해야한다.
2) 기도를 통한 도움
3) 경전(성서, 불경 등)이나 다른 종교서적의 사용
4) 종교 예식에 참여하도록 돕고 조용한 환경을 유지해준다.
5) 대상자의 영적 지도자나 원목자의 도움
6) 음악의 사용

6. 환자 또는 보호자에게 사회적 · 정신적지지 제공

가. 가족도 부정, 분노, 협상, 우울, 용납의 과정을 밟는 것을 이해하고 그것이 정상임을 이해시킨다.

나. 환자의 사망 후에는 상실, 사별의 현실을 수용하고 적응토록 지지해 준다.

다. 마음속에 있는 감정을 표현하도록 하여 여러 감정을 해소토록 지지해 준다.

라. 가급적 환자의 옆에서 지킬 수 있도록 지지해 주며, 무리한 상황일 경우는 쉬도록 해준다.

마. 가족의 급성 질환 발생은 처음 6주가 심하고 1년이 지나야 소실된다. (위장장애가 많고, 병에 대한 내성이 약해 사망률이 높아진다).

바. 생애말기환자는 생명을 연장시키는 치료가 아닌, 고통 받는 증상에 대한 치료가 중요하므로 의료인이 환자 또는 보호자에게 증상에 대한 치료에 대해 설명하고 치료결정 시에 참여시킨다.

사. 의료인이 생애말기환자 또는 보호자에게 고통과 슬픔에 대한 정신•사회적지지(예시 : 환자 또는 가족에게 교육 및 상담, 위로와 격려, 따듯하고 아늑한 병실 분위기 조성, 환자 옆에서 손잡아주기, 대화 등)를 제공한다.

7. 생애말기환자 발생 시 직원의 역할

가. 의사

1) 일반적인 의학 분야에 능통해야 하고, 통증 조절과 다른 증상 관리에도 숙달되어야 한다.
2) 환자 질병 관리와 관련된 지침에도 익숙해야 한다.
3) 의학적 치료의 갈등 상황에 대한 평가, 감독 및 조정의 역할을 한다.

4) 의학적 의사결정에 대해 논의하고, 연구와 연구 결과의 적용을 판단하는 통합적인 역할을 수행한다.
5) 신체적인 문제(통증, 다른 증상)에 대해 적극적으로 관리한다. (통증 : 진통제 등으로 통증 조절)
6) 식이 : 필요시 정맥 영양 및 경관영양 시행 등

나. 간호사

1) 전형적으로 환자와 가장 많이 접촉하는 의료인으로서 지속적으로 환자 상태를 사정한다.
2) 환자에게 신체적 및 심리, 사회적, 영적인 측면을 포괄하는 전인간호를 제공한다.
3) 통증을 포함한 환자의 증상 관리, 환자 및 가족의 교육, 간호 상담, 가족지지, 임종돌봄 그리고 일상생활에서 환자의 상태에 따라 최적의 건강 기능을 적절히 유지할 수 있도록 돕는다.
4) 안전한 환경에서 돌봄을 받을 수 있도록 간호한다.

다. 사회복지사

1) 가족과 환자가 질환과 장애로 인한 개인적, 사회적 문제를 관리할 수 있도록 돕는다.
2) 질병의 진행과 사별 과정에서 지지를 제공하는 역할을 담당한다.
3) 심리사회적 관점에서 환자와 가족의 요구를 평가한다.
4) 환자의 기능저하와 경제적 어려움에서 비롯되는 가족내의 문제를 예견하여 지원을 제공한다.
5) 지역사회의 자원과 연결하거나, 환자나 가족 개인을 포함한 정서적인 지지를 제공한다.
6) 상담이 필요한 경우 [5.4 의료사회복지체계] 에 따라 심리사회적 상담을 실시하며 상담일지를 기록한다.

▣ 규정 개정일 [누적]

2025년 10월 15일 개정하고 2025년 11월 1일 시행한다.

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일	. . .				